

Fecha Última Actualización: 07-09-2022 8:22:52

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Maria Del Transito Fuentes Fernandez
Edad : 78a 5m 8d
Dirección : Diego Rojas 13207

Rut : 4.999.566-0
Fecha Nacto: 24/03/1944
Comuna : El Bosque

N° Archivo : 2213673
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 5001 1068

N° Epicrisis
317555

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Recuperación (Tránsito Pabellón)

Fecha Ingreso : 08/07/2022 07:00

Días Estadía: 55

Unidad de Egreso : Utac/ Utinx

Fecha Egreso : 01/09/2022 13:45

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Hemorragia Subaracnoidea, No Especificada

Comorbilidades

Hipertensión Arterial; Glaucoma; Artrosis; Obesidad; Trastorno Depresivo Mayor;

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: María del Transito Fuentes Fernandez
Edad: 78 años
FI HSR: 08/07/22
FI UPC: 09/07/22
FI UTINCX: 05/08/22
RUT: 4999566-0

Antecedentes:

Médicos: HTA sin tratamiento, Gonartrosis, Glaucoma, Depresión, Obesidad.

Fármacos: Brinzolamida 1% Suspension Oftálmica, 1 Gota cada 12 horas, Bimatoprost 0.01% / Brimonidina 0,15% / Timolol 0,5% Solución Oftálmica 1 gota cada 12 horas, Alprazolam 0,50 mg al día.

Quirúrgicos: no conocidos.

Alergias: no conocidas.

Hábitos: TBQ no, OH no, drogas no.

Inmunizaciones: esquema vacunación completado, infección por SARS COV-2 asintomático en enero de 2022.

Motivo de ingreso: Cefalea ictal

Historia clínica

Paciente consulta por cuadro que inicia aproximadamente a las 19:00 Hrs, caracterizado por cefalea ictal, compromiso de conciencia, náuseas y vómitos. Acude al hospital Padre Hurtado, en donde ingresa en GSC 14/15, se realiza TC de cerebro compatible con HSA aneurismática (ACA izquierda), por lo que es derivada al servicio de urgencias HSR, donde ingresa el 08/07/2022 a las 06:11H aproximadamente, se describe en el DAU con sensorio fluctuante, vigil al estímulo verbal continuo, emite muy escaso lenguaje, sigue instrucciones muy escasas, impresiona afásica, isocórica, m5 en 4 extremidades, rigidez de nuca. PCR SARS COV 2 positiva.

Se decide angiografía diagnóstica, procedimiento bajo anestesia general, por lo que requiere intubación orotraqueal y línea

Fecha Epicrisis : 07/09/2022 08:22

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 07-09-2022 8:22:52

Página 2 de 4

arterial. Se identifica aneurisma sacular del complejo comunicante anterior, cuello 2.2 mm y fondo 2x4 x 2.5 mm, no existe A1 derecha (ambas ACA se irrigan por el lado izquierdo).
Se decide colocación de DVE y clipaje abierto.

Bajo anestesia general, se coloca DVE, luego se realizan 3 clipajes transitorios de 5 minutos cada uno, separados por otros 3 minutos de espera entre ellos. Se logra disecar el aneurisma completamente, incluyendo ambas A2. Se realiza clipaje definitivo de aneurisma con clip estándar.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO A UPC HSR:

1. HSA Fisher IV
- postop día 2 Clipaje abierto de ACA e instalación de DVE (09/07)
2. Insuficiencia respiratoria aguda NAC Aspirativa
3. PCR COVID-19 (+) al ingreso.

EVOLUCIÓN DURANTE HOSPITALIZACIÓN (UPC 08/07 al 05/08 y UTIN 05/08 al 29/08):

1. Hemodinámica: en UCI con DVA en contexto de metas de PAM como medida de neuroprotección. Requiere aumento de DVA en contexto de uso de Milrinona por Vasoespasmo + sepsis foco respiratorio. Cursó con hipotensión en contexto de insuficiencia suprarrenal central, suplementada con hidrocortisona sin problemas. Se suspenden DVA el 06/08 sin incidentes. Actualmente con episodios de hipotensión (Corticoides suspendidos por adecuación de esfuerzo terapéutico), pero en general normotensa logrando PAM sobre 65 mmHg autolimitada.

RESPIRATORIO: al ingreso PCR SARS-CoV-2 (+), pero con antecedente de infección reciente en enero de 2022. EN UPC cursó con NAVM por PSAE tratada. Dado intubación prolongada, se define traqueostomía percutánea realizada el 26/07 para facilitar weaning. Logra destete de VMI el 28/07, sin incidentes. Cursó con 2 EPA en contexto de sobrevolemización, manejados con CPAP + diuréticos, con buena respuesta. Se mantiene con secreciones. KNTR + SBT. Por mala mecánica ventilatoria se inicia morfina, con buena respuesta

INFECCIOSO: múltiples interurrencias infecciosas, actualmente, cursando ITS x PSAE de origen CVC vs respiratorio (Cultivo de arastre y CAET + para PSAE MR) completó 7 días con amikacina ciprofloxacino. Se acuerda con familiares no dar más terapias ATB posterior a esta. Previas:

- Neumonía aspirativa por PAE MS, recibió ceftazidima
- NAAS por PAE, manejada con ceftazidima (7) + amikacina NBZ (7)
- LCR (+) del 30/07 para S.cohnii MR. Se inicio vancomicina (6). Discutido con infectología les impresiona contaminación, por lo que se suspendió tto.
- ITS/CVC Pseudomona Aeruginosa MS, ayer completa 10 días de ceftazidima.

NEUROQUIRÚRGICO: HSA Fisher IV con clipaje abierto de ACA e instalación d e DVE por hidrocefalo. Cursa con Vasoespasmo por AngioTAC (13/07), con lo que completó 7 días Milrinona aparente buena respuesta (aunque no logró tener dosis en rango). Múltiples pruebas de cierre fallidas. Dado evolución negativa en lo neurológico a pesar de tto anticonvulsivante y modafinilo, se retira DVE el 28/08 en contexto de adecuación de esfuerzo terapéutico.

Neurológico: Presentó crisis epilépticas y EEG con AE persistente, se mantiene con fenitoína, levetiracetam y clonazepam. Monitoreo EEG 10 al 11/8 con ocasional AEI anterior izquierda. PHT ajustada por NPL a 200 mg cada 12 hrs. Nuevo control NP 12,4 corregido por albúmina. Se mantiene esquema de FAEs y retira modafinilo.

REHABILITACIÓN:

- KNT Motora: Kinesioterapia SBC + KNTR.
- FNA: Alimentándose por SNG . No se hará GTT (LET)

OFTALMOLÓGICO: tratamiento crónico para Glaucoma. Sin cambios de momento.

RENAL/MEDIO INTERNO: Paciente evoluciona sin falla renal. tendencia a hipernatremia, manejada con agua libre.

Fecha Epicrisis : 07/09/2022 08:22

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 07-09-2022 8:22:52

Página 3 de 4

GASTRO/NUTRICIONAL: Evoluciono con diarrea durante estadía en UCI. Se solicitó toxina CD que resultó negativa. Actualmente resuelta.

Profilaxis: tromboprofilaxis con HBPM y gástrica con IBP.

Manejo: Hasta intermedio. No RCP. Se conversa con familia, se decide no TOT, no RCP. AET: no más ATB una vez completado el esquema actual, no nuevas intervenciones quirúrgicas. (Documento firmado en ficha)

Se inició tratamiento paliativo no oncológico de paciente, con evaluación integral de paliativo. Se suspendieron terapias prescindibles, manteniendo terapia antibiótica.

Paciente con deterioro vital progresivo, fallece de falla respiratoria el 01/09/2022. Se constata fallecimiento.

Diagnósticos de egreso:

1. Paro cardiorrespiratorio

- Falla respiratoria aguda.

2. HSA Fisher IV.

·Clipaje abierto de ACA e instalación de DVE (09/07).

·Vasoespasma - protocolo Milrinona completado (8 días)

·Intentos cierre DVE frustrados - Cambio DVE 02/08.

·Compromiso de conciencia multifactorial persistente.

3. Insuficiencia suprarrenal central en tratamiento

4. ITS x PAE de origen CVC tratada

5. Insuficiencia respiratoria aguda NAC Aspirativa por PSAE MS tratada

6. EPA 08/08 resuelto

7. TQT 16/07, retirada 30/08

8. Intercurrencias infecciosas:

·Neumonía aspirativa por PAE MS, recibió ceftazidima + amikacina NBZ (7).

·ITS/CVC Pseudomona Aeruginosa MS, completó 10 días de ceftazidima.

·PCR COVID-19 (+) al ingreso, resuelto.

9. Antecedentes: HTA sin tratamiento, Artrosis de rodilla, Glaucoma, Depresión, Obesidad SARS COV 2 positiva asintomática enero 2022.

Diagnóstico de Egreso

Hemorragia subaracnoidea aneurismática - Clipada

Neumonía Asociada a Ventilación mecánica (NAVIM) - Psae

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Fallecido

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 07/09/2022 08:22

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:03

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 07-09-2022 8:22:52

Página 4 de 4



Beatriz Matilde Tapia Peschke

Becado/Residente



Martín Lopez Abelleira

Médico Tratante (Staff)

INTERNO